

РАК ЖЕЛУДКА
УДК:616.33-006-64-082

А.Ж.Жылкайдарова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

**Оценка динамики показателей заболеваемости
и смертности от рака желудка в Казахстане
за 2004-2014 годы**

Аннотация. В Казахстане отмечается высокий уровень заболеваемости и смертности от рака желудка (РЖ). В целях мониторинга был проведен эпидемиологический анализ распространения рака желудка (РЖ) у населения Казахстана за 2004-2014 года для оценки оказания онкологической помощи и лечебно-профилактических мероприятий. Отмечена тенденция снижения первичной заболеваемости РЖ с 22,3‰ до 17,2‰ и смертности от РЖ с 18,7‰ до 12,9‰ (стандартизированные WHO World показатели). Мужчины в 2,5 раза чаще болели чем женщины. Выделены регионы с высоким уровнем заболеваемости (Павлодарская, Кызылординская, Актюбинская, Акмолинская области). В 2009-2014 гг. отмечено увеличение уровня заболеваемости в г. Астана, в Жамбылской, Акмолинской, Актюбинской областях, снижение – в Северо-Казахстанской и Мангистауской областях. Отмечено увеличение удельного веса I-II стадий в 1,8 раз. Соотношение показателя заболеваемости к смертности за этот период снизилось с 83,9% до 66,6%, что свидетельствует об улучшении параметров оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан. Выявленные особенности заболеваемости и смертности от РЖ на территории РК будут учтены при дальнейшем расширении скрининга и перспективном планировании лечебно-диагностических мероприятий.

Ключевые слова: рак желудка, заболеваемость, смертность, Республика Казахстан.

Введение. Среди различных стран мира заболеваемость раком желудка находится на высоком уровне. Согласно базе данных GLOBOCAN, число заболевших злокачественными новообразованиями (ЗНО) желудка в 2012 году составило 951 594 человек, число умерших – 723 073 [1]. Среднемировая заболеваемость составила 12,1‰ (17,4‰ среди мужчин и 7,5‰ среди женщин) – 6 место в структуре онкозаболеваемости, смертность 8,9‰ (12,8‰ среди мужчин и 5,7‰ среди женщин), 4 место в структуре онкосмертности. Отношение смертности к заболеваемости составляет 73,6%.

Материалы и методы. Объектом исследования явились уточненные сведения 198 «Отчетов о заболеваниях злокачественными новообразованиями» и «Отчетов о больных злокачественными новообразованиями» (форма № 7, форма № 35, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № 128 от 6 марта 2013 г.) за 2004-2014 гг. (сплошная выборка); информация из «Извещений о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования» (форма № 090/у, утверж-

денная Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № 514 от 31 июля 2012 г.); данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по численности и половозрастному составу населения Казахстана за 2004-2014 гг. Всего в Казахстане за 2004-2014 гг. было зарегистрировано 30 699 больных ЗНО желудка, умерло – 25 013 человек. Материалы были проанализированы в целом по республике, а также с учетом административно-территориального деления на 14 областей и 2 города республиканского значения Астана и Алматы. Использованы традиционные методы статистической обработки материала [2, 3, 4]. Вычислены экстенсивные, интенсивные, стандартизированные и по возрастные показатели заболеваемости на 100 тысяч населения, смертность на 100 тысяч населения. Для вычисления статистических показателей использованы методики, рекомендуемые Международным Агентством по исследованию рака (МАИР) [5]. Для расчета стандартизированных показателей в качестве стандарта применялась мировая стандартная численность населения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [6]. Для оценки состояния онкологической помощи использовались показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2008 и 2014 гг. [7, 8].

Результаты. Уровни заболеваемости (на 100 000 жителей, приведенных по возрастной структуре к мировому стандарту World) по странам колеблются от 2,2‰ в Польше и Эстонии до 41,8‰ в Корее (таблица 1). Казахстан входит в группу стран с высоким уровнем заболеваемости. Оценочные показатели ВОЗ, GLOBOCAN 2012 несколько превышают реальные показатели Электронного регистра онкологических больных Республики Казахстан. Это является следствием методологических расчетов, использованных МАИР при формировании базы GLOBOCAN 2012, когда национальные показатели заболеваемости рассчитываются исходя из показателей 5-летней выживаемости [9].

Во всех странах наблюдаются существенные различия в заболеваемости по полу: мужчины в 2 и более раз чаще болеют ЗНО желудка, чем женщины. В Казахстане половые различия также выражены, заболеваемость среди мужчин превалирует над заболеваемостью среди женщин в 2,6 раз.

Показатель «отношение смертности к заболеваемости», характеризующий уровень развития онкологической службы в той или иной стране, является высоким как в развитых, так и в развивающихся странах, что свидетельствует о серьезности проблемы радикального лечения ЗНО желудка и необходи-

мости их раннего выявления. Низкие показатели отношения смертности к заболеваемости отмечаются в Японии (41,5%) и Корее (31,1%), а в Дании, Канаде и Эстонии эти показатели приближаются к отметке 100% или превышают её. В Казахстане этот показатель равен 77,8%. Важно отметить, что, по сведениям GLOBOCAN 2012, отношение указанных показателей для Казах-

стана выглядит несколько хуже (83,5%), чем по уточненным сведениям Электронного регистра онкологических больных Республики Казахстан. Эти различия служат подтверждением определенного прогресса в ранней диагностике и лечении одной из сложных локализаций рака.

Таблица 1- Заболеваемость раком желудка и смертность от него в отдельных странах мира в 2012 году (на 100 000 населения, мировой стандарт World, данные GLOBOCAN 2012)

Страны	Заболеваемость			Смертность			Отношение смертности к заболеваемости,%
	Мужчины	Женщины	Оба пола	Мужчины	Женщины	Оба пола	
Казахстан*	35,25	12,79	21,6	30,4	10,5	18,0	83,5
Казахстан**	21,5	11,7	16,5	24,6	9,3	12,8	77,6
Казахстан***	28,7	11,1	18,0	22,0	8,7	14,0	77,8
Кыргызстан	6,9	10,27	21,4	33,0	9,5	19,6	91,9
Российская Федерация	6,4	0,9	3,1	5,9	0,7	2,7	87,1
Узбекистан	16,8	8,8	12,5	15,6	8,1	11,4	91,2
Украина	5,5	0,5	2,5	4,5	0,3	2,0	80,0
Великобритания	10,0	3,5	6,5	8,7	2,9	5,6	86,2
Германия	6,9	1,3	4,0	4,5	1,1	2,7	67,5
Дания	5,6	2,4	3,9	6,5	1,9	4,1	105,1
Латвия	7,1	1,0	3,5	6,8	0,7	3,2	91,4
Литва	7,6	0,8	3,6	7,4	0,7	3,5	97,2
Нидерланды	10,0	2,8	6,3	8,3	2,3	5,2	82,5
Польша	4,0	0,8	2,2	3,8	0,7	2,1	95,5
Словакия	6,4	0,8	3,4	5,8	0,7	3,0	88,2
Финляндия	3,7	1,1	2,3	3,0	1,0	1,9	82,6
Франция	6,1	1,7	3,8	5,1	1,0	2,9	76,3
Швейцария	6,1	1,9	3,8	4,4	1,1	2,6	68,4
Швеция	3,5	1,1	2,3	3,1	0,9	2,0	87,0
Эстония	4,5	0,6	2,2	5,1	0,3	2,2	100,0
Канада	4,6	1,1	2,8	4,6	1,0	2,7	96,4
США	5,5	1,1	3,2	5,1	1,0	2,9	90,6
Китай	32,8	13,1	22,7	25,5	10,7	17,9	78,9
Корея	62,3	8,8	41,8	13,6	7,9	13,0	31,1
Япония	45,8	16,5	29,9	18,8	7,3	12,4	41,5
Австралия	6,7	3,1	4,8	3,5	1,6	2,5	52,1
Бразилия	13,1	6	9,2	10,9	4,6	7,4	80,4
* по данным ВОЗ, GLOBOCAN 2012							
** по данным ЭРОБ РК, интенсивные (грубые) показатели							
*** по данным ЭРОБ РК, стандартизованные показатели							

Анализ интенсивных и стандартизированных показателей заболеваемости раком желудка (рисунок 1) говорит о снижении частоты выявления новых случаев заболевания. За 2004-2014 годы отмечается тенденция снижения первичной заболеваемости с 20,0‰ до 16,4‰. Стандартизированные показатели имеют схожую картину снижения частоты заболеваемости. Коэффициент регрессии стандартизированных показателей практически не отличается от соответствующего коэффициента интенсивных показателей, что говорит об отсутствии влияния старения населения на уровень заболеваемости. Снижение уровня заболеваемости также говорит об уменьшении влияния неблагоприятных этиологических факторов.

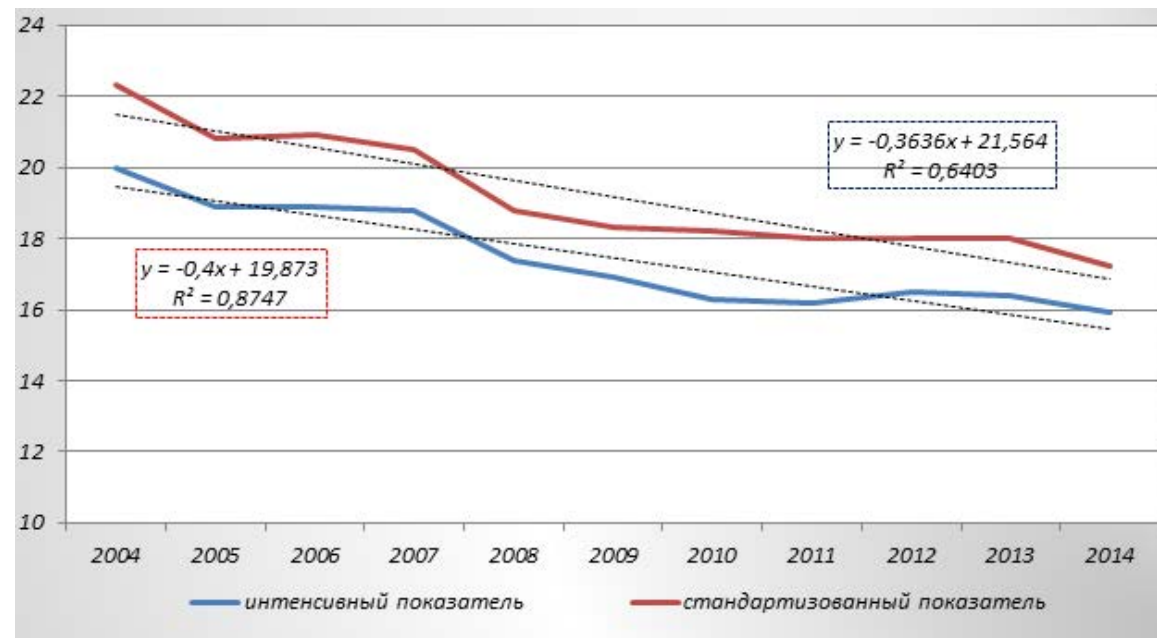


Рисунок 1 - Динамика интенсивных и стандартизованных WHO World показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями желудка на 100 000 населения Республики Казахстан за период 2004-2014 годы

Распределение заболеваемости по полу

При рассмотрении уровня заболеваемости раком желудка (рисунок 2) отмечено различие в уровнях заболеваемости по полу. Как в период 2004-2008 гг., так и в период 2009-2014 гг., мужчины в 2,5 раза чаще болели чем женщины, что в среднем не отличается от других стран мира.

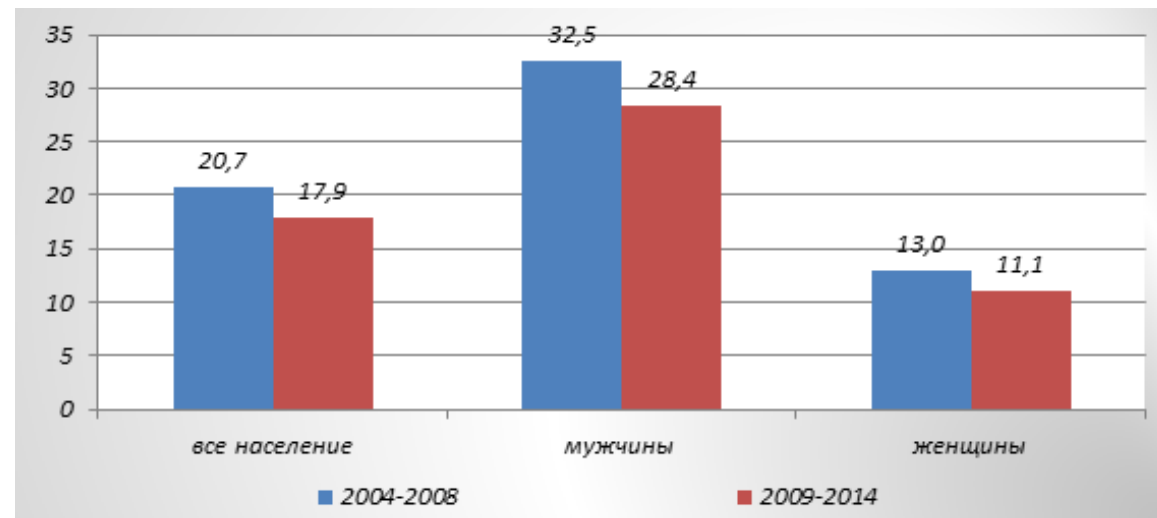


Рисунок 2 - Уровни заболеваемости злокачественными новообразованиями желудка населения Республики Казахстан в зависимости от пола (стандартизованные показатели WHO World на 100 000 населения за 2004-2008 и 2009-2014 годы)

Распределение заболеваемости по возрасту

Анализ возрастного распределения заболеваемости ЗНО желудка (рисунок 3) показывает увеличение данного показателя начиная с 40-44 лет, с неуклонным ростом и максимальными показателями в возрасте 70 лет как в период 2004-2008 гг., так и в период 2009-2014 гг.

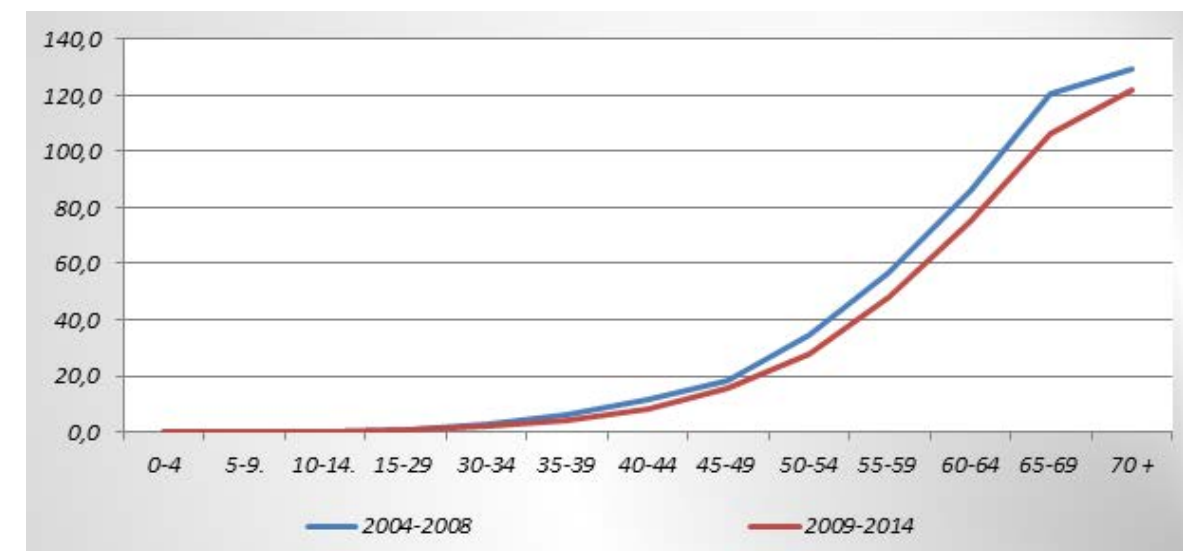


Рисунок 3 - Возрастные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями желудка населения Республики Казахстан (средние показатели на 100 000 жителей соответствующего возраста за 2004-2008 и 2009-2014 годы)

Как мужчины, так и женщины имеют максимальный уровень заболеваемости в возрасте 70 лет и старше, и возрастная динамика обоих полов схожа: уровень заболеваемости возрастает начиная с 40-44 лет и продолжает неуклонно расти.

Распределение заболеваемости по территории страны

Территориальное распределение заболеваемости ЗНО желудка (рисунок 4) позволяет выделить регионы с высоким уровнем заболеваемости (Павлодарская, Кызылординская, Актюбинская, Акмолинская области). Остальные регионы находятся приблизительно на одном уровне. Следует отметить увеличение уровня заболеваемости в период 2009-2014 гг. по сравнению с периодом 2004-2008 гг. в г. Астана, Жамбылской, Акмолинской, Актюбинской областях. В СКО и Мангыстауской областях в период 2009-2014 годов наблюдалось незначительное снижение заболеваемости по сравнению с периодом 2004-2008 годов.

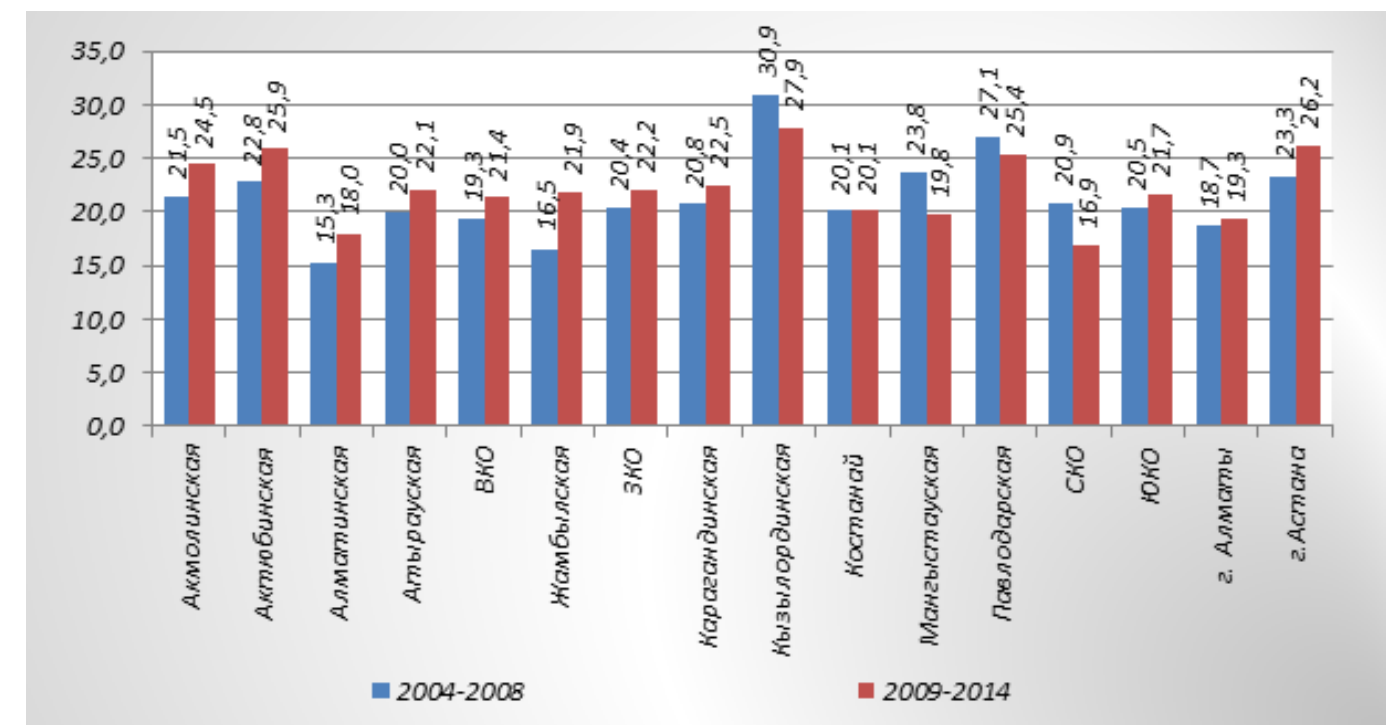


Рисунок 4 - Территориальные уровни заболеваемости злокачественными новообразованиями желудка населения Республики Казахстан (стандартизованные показатели WHO World на 100 000 населения, за 2004-2008 и 2009-2014 годы)

Удельный вес I-II, III и IV стадий

Среди вновь выявленных случаев ЗНО желудка за 2004-2014 годы, наглядно отмечается увеличение удельного веса I-II стадии в 1,8 раз (15,7% – 27,6%) за счет уменьшения удельного веса IV стадии за указанный период с 30,3% до 25,0% и III стадии с 51,1% до 44,8% (рисунок 5).

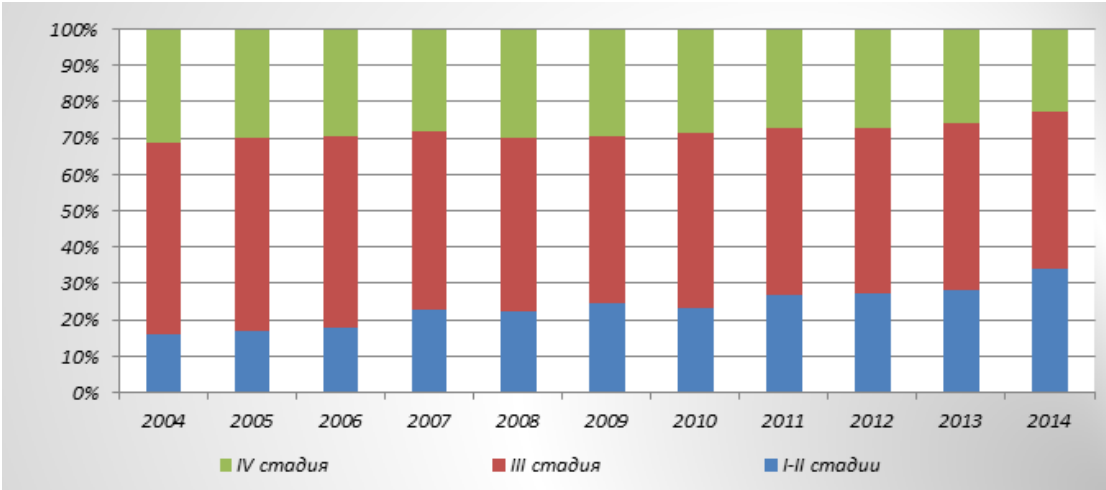


Рисунок 5 - Удельный вес I-II, III и IV стадий вновь выявленных случаев злокачественных новообразований желудка населения Республики Казахстан (%)

Состояние онкологической помощи

Таблица 2 - Основные статистические показатели рака желудка

Показатель	2008	2013
Число впервые выявленных случаев	2726	2796
Заболеваемость на 100 000 населения (грубый интенсивный показатель)	17,4	16,4
Заболеваемость на 100 000 населения (стандартизованный WHO World показатель)	18,8	18,0
Удельный вес I-II стадий (% к вновь выявленным случаям)	21,9	27,6
Удельный вес IV стадии (% к вновь выявленным случаям)	46,7	44,8
Число впервые выявленных при скрининге	85	193
Выявляемость скрининга (% к числу осмотренных)	3,1	6,9
Подтверждено морфологически (% к выявленным случаям)	83,8	87,5
Прожили менее одного года с момента установления диагноза из числа зарегистрированных в предыдущем году (одногодичная летальность в%)	57,5	51,4
Получили лечение по радикальной программе (% из числа вновь заболевших, получивших комплексное лечение)	31,6	37,9
Умерло от злокачественных новообразований желудка	2251	2129
Смертность на 100 000 населения (грубый интенсивный показатель)	15,2	14,6
Смертность на 100 000 населения (стандартизованный WHO World показатель)	16,5	16,5
Отношение смертности и заболеваемости в% (интенсивные показатели)	87,4	89,0
Отношение смертности и заболеваемости в% (стандартизованные показатели)	87,8	91,7
Число пациентов, состоящих на учете на конец года	6584	6075
Из них состоящих на учете 5 лет и более (%)	40,5	45,3

В таблице 2 представлены основные статистические показатели, характеризующие состояние онкологической помощи пациентам с ЗНО желудка [7, 8]. Число вновь зарегистрированных случаев в 2013 году увеличилось на 2,6% по сравнению с 2008 году, число морфологических подтверждений увеличилось на 3,7% и составило 87,5%. Удельный вес I-II стадий увеличился в 2013 году на 5,7% по сравнению с 2008 годом, кроме того отмечается снижение удельного веса IV стадии на 1,9% и составил 44,8% в 2014 году. Одногодичная летальность снизилась на 6,1%, что говорит об улучшении своевременной диагностики ЗНО желудка. Число пациентов, получивших лечение по радикальной схеме, увеличилось на 6,3% и составило 37,9%. Изменения за 5 лет имеются, однако они незначительные. Кроме того, превышение удельного веса запущенных стадий по сравнению с ранней стадией заболевания раком желудка в 2,1 раз в 2008 году и в 1,6 раз в 2013 году свидетельствует о серьезности проблемы ранней диагностики рака желудка.

Уровень смертности с 2004 года по 2014 год в динамике снижался: интенсивные показатели – с 16,7‰ до 11,9‰, стандартизованные – с 18,7‰ до 12,9‰ (рисунок 6). Показатель «отношение смертности к заболеваемости» с 2004 года по 2014 год имеет волнообразный характер с повышением (до 87,8% в 2008 году) и снижением в различные годы. Фактически, с 2004 до 2010 года отмечается стабилизация показателя «отношение смертности к заболеваемости» на уровне 85%. С 2010 года тренд снижения уровня смертности имеет устойчивый характер, что подтверждается относительно высоким коэффициентом регрессии $R^2 = 0,6507$. За указанный период показатель соотношения стандартизованных по возрасту смертности и заболеваемости снизился до 66,6% в 2014 году, что сопоставимо с такими странами, как Германия и Швейцария [1].

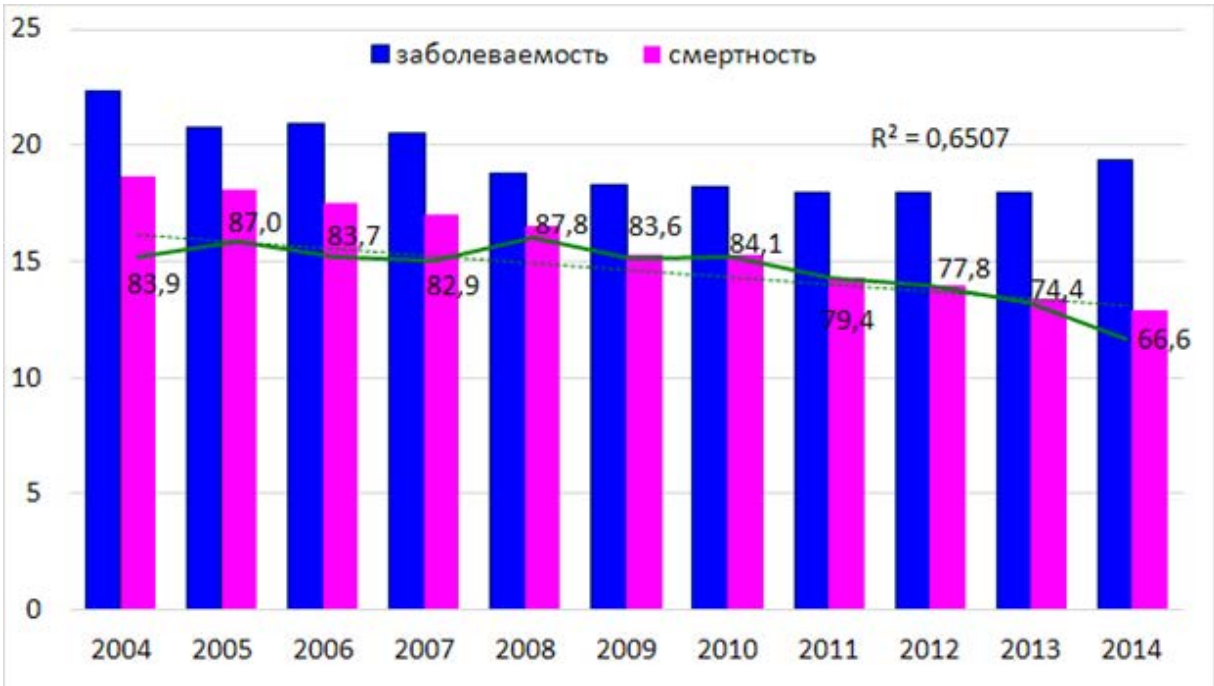


Рисунок 6 - Злокачественные новообразования желудка: заболеваемость, смертность (интенсивные показатели), отношение показателей смертности к заболеваемости (%) за 2004-2014 годы

С целью снижения смертности от рака желудка с 2013 года в пилотном режиме внедрен эндоскопический скрининг, направленный на раннее выявление рака пищевода и желудка. В настоящее время скрининг проводится в 11 регионах Казахстана с охватом около 330 тысяч мужчин и женщин от 50 до 60 лет каждые 2 года. Ежегодный охват соответствует 50% подлежащего населения. Безусловно, имеются определенные проблемы с реализацией данного скрининга, однако даже первые годы внедрения скрининга отразились на эпидемиологической картине рака желудка – впервые за более чем 10 лет в 2014 году отмечен рост заболеваемости данной патологией. Лишь в последние 5 лет с 2010 года отмечена тенденция снижения смертности от рака желудка.

Выводы. Анализ динамики распространенности рака желудка в Казахстане показывает достаточно стабильную и в то же время неблагоприятную ситуацию. Только в последние 5 лет отмечаются небольшие положительные тенденции: к снижению смертности, что более очевидно по интенсивным показателям, увеличения удельного веса ранних стадий, уменьшение показателя соотношения смертности к заболеваемости. Реализация Государственной программы «Саламатты Қазақстан», Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан, старт программы скрининга рака пищевода и желудка позволили начать процесс оснащения амбулаторно-поликлинических организаций современным эндоскопическим оборудованием, подготовки кадров, повышения информированности населения по вопросам онконастороженности и ранней диагностики онкозаболеваний. Выявленные особенности заболеваемости и смертности от рака желудка на территории Республики Казахстан необходимо учитывать при перспективном планировании лечебно-профилактических мероприятий, расширении и оценке качества скрининга рака пищевода и желудка, а также для совершенствования онкологической помощи данной категории больных.

Список использованной литературы

1. GLOBOCAN 2012 (IARC). Section of Cancer Information. Доступно по адресу: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx.
2. Двойрин В.В. Методы эпидемиологических исследований при злокачественных опухолях. – М.: Медицина, 1975. – 323 с.
3. Гланц С. Медико-биологическая статистика/Пер. с англ. – М.: Практика, 1998. – 459 с.
4. Кокрен У. Методы выборочного исследования/Пер. с англ. И.М. Сониной. – М.: Статистика, 1976. – 440 с.
5. Организация онкологической службы в России (методические рекомендации, пособие для врачей) Часть 2 / Под редакцией Чисова В.И., Старинского В.В., Ковалева Б.Н. – М.: ФГУ МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий, 2007. – 663 с.
6. Age standardization of rates: a new WHO world standard / O.B. Ahmad [et al.] // World Health Organization [Electronic resource]. – 2001. – Доступно по адресу: <http://www.who.int/entity/healthinfo/paper31.pdf>.
7. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2008 год: статистические материалы. – Алматы: КазНИИОиР, 2009. – 100 с.
8. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2013 год: статистические материалы. – Алматы: КазНИИОиР, 2014. – 100 с.
9. Antoni S., Soerjomataram I., Møller B. et al. An assessment of GLOBOCAN methods for deriving national estimates of cancer incidence - Bulletin of the World Health Organization. – 2016. – Vol. 94. – P.174-184. doi: <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.15.164384>.

ТҰЖЫРЫМ

А.Ж.Жылқайдарова

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты, Алматы қ.

2004-2014 жылдары Қазақстанда асқазанның қатерлі ісігімен ауыру және өлім көрсеткіштерінің динамикасын бағалау

Қазақстанда асқазан қатерлі ісігі ауруына (АҚІ) шалдығу мен өлім деңгейінің жоғарылауы байқалады. Онкологиялық көмек пен емдеу-профилактикалық іс-шаралардың көрсетілуін бағалау үшін 2004-2014 жылдары Қазақстан тұрғындарында АҚІ-нің таралуын бақылау мақсатында эпидемиологиялық талдау жүргізілді. АҚІ-мен алғашқы сырқаттанушылықтың 22,3%000-дан 17,2%000-ға дейін, АҚІ-ден болған өлімнің 18,7%000-дан 12,9%000-ға дейін (стандартталған WHO World көрсеткіштері бойынша) төмендеу үрдісі белгіленген. Ер адамдар әйелдерге қарағанда 2,5 есе жиі ауырады. Сырқаттанушылықтың жоғары деңгейі (Павлодар, Қызылорда, Ақтөбе, Ақмола облыстары) өңірлерінде анықталды. 2009-2014 жылдары сырқаттанушылық деңгейінің артуы – Астана қ., Жамбыл, Ақмола, Ақтөбе облыстарында, төмендеуі – Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау облыстарында байқалды. I-II сатыдағы АҚІ үлес салмағы 1,8 есеге артқан. Осы кезеңдегі сырқаттанушылық көрсеткішінің өлімге арақатынасы 83,9%-дан 66,6%-ға дейін азайған, бұл Қазақстан Республикасының тұрғындарына онкологиялық көмек көрсетілу параметрлерінің жақсарғанын куәландырады. ҚР аумағында сырқаттанушылықтың және АҚІ-ден болған өлімнің анықталған ерекшеліктері скринингті әрі қарай кеңейтуде және емдеу-диагностикалық іс-шараларды перспективалық жоспарлауда ескеріледі.

Түйінді сөздер: асқазанның қатерлі ісігі, сырқаттанушылық, өлім, Қазақстан Республикасы.

SUMMARY

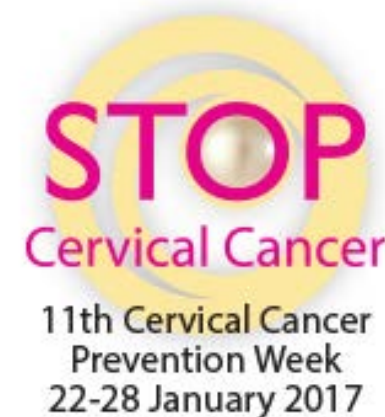
A.Zhylkaidarova

Kazakh Institute of Oncology and Radiology, Almaty

Stomach cancer incidence and mortality dynamics in Kazakhstan in 2004-2014

Kazakhstan has a high level of stomach cancer (SC) incidence and mortality. Epidemiological analysis of SC prevalence in Kazakhstan during 2004-2014 was conducted for the purposes of monitoring and assessment of cancer care, treatment and preventive measures. Primary SC incidence and mortality have decreased from 22.3%000 to 17.2%000, and from 18.7%000 to 12.9%000, respectively (standardized WHO World indices). SC incidence in men was 2.5 times higher than in women. Several regions like Pavlodar, Kyzylorda, Aktobe, and Akmola had a high SC incidence. In 2009-2014, the incidence has increased in Astana, Zhambyl, Akmola, Aktobe regions, with a decrease in North Kazakhstan and Mangistau regions. The proportion of stages I-II increased by 1.8 times. The ratio of mortality to incidence for the period has decreased from 83.9% to 66.6% what indicates an improvement in cancer care in the Republic of Kazakhstan. The revealed features of SC incidence and mortality in the Republic of Kazakhstan will be taken into account during further expansion of screening and long-term planning of treatment and diagnostic measures.

Keywords: stomach cancer, incidence, mortality, the Republic of Kazakhstan.



С 23 по 29 января 2017 г. в Казахстане традиционно прошла Неделя осведомленности о раке шейки матки. В рамках мероприятий, запланированных Министерством здравоохранения и социального развития, Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии (КазНИИОиР), Управлениями здравоохранения и региональными онкологическими центрами по всей стране, мы пригласили женщин всех возрастов для прохождения бесплатного гинекологического осмотра со взятием пап-теста (мазка с шейки матки для проверки на наличие атипичных клеток).

Прохождение пап-теста представилось в Казахстане в рамках Государственной программы по развитию онкологической службы всем женщинам в возрасте от 30 до 60 лет с интервалом один раз в пять лет.

28 января 2017 г. в рамках Недели осведомленности о раке шейки матки пап-тест проводился на бесплатной основе всем желающим. Также в этот день в онкологических учреждениях по всей стране прошли дни открытых дверей, где женщины получили бесплатную консультацию у гинеколога-онколога.

28 января с 9.00 до 14.00 День открытых дверей по раннему выявлению рака шейки матки прошел в Казахском НИИ онкологии и радиологии в Алматы.

